PROTOCOLLO 52

Contrazione e rilassamento dei muscoli elevatori

Aumentare l'apertura sfruttando il rilassamento post isometrico

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia con limitazione	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Apertura limitata da tensione muscolare
- ✓ Resistenza all'allungamento passivo
- ✓ Paziente collaborante

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: seduto o supino.

Fisioterapista: di fronte al paziente, due dita sotto il mento o sugli incisivi inferiori.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Apertura fino alla prima resistenza.



Contrazione
Il paziente spinge lievemente in chiusura contro la tua resistenza.



Rilassamento
Dopo 5 secondi rilascia e respira.



Nuovo limite
Accompagna l'apertura fino alla nuova barriera.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Contrazione	20 % della forza, 5 secondi
Ripetizioni	3 a 5
Pausa	rilassamento completo

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Forza di contrazione molto bassa
- ✓ Sincronizza con l'espirazione
- ✓ Misura l'apertura dopo la tecnica

Errori da evitare

- ! Contrazioni intense
- ! Forzare l'apertura
- ! Saltare la fase di rilassamento

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autotrattamento	Chiusura isometrica lieve contro le dita e poi apertura	5 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il rilassamento post isometrico è efficace e ben tollerato quando la limitazione è muscolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.